

Guía de Estudio de Patología Oral (Capítulo 8)

Repaso Enfocado para el Examen NBDHE (Preguntas 1 a 50 y Casos Clínicos A y B)

Cómo usar esta guía: Estudie primero los recuadros amarillos marcados como "Concepto Clave". Contienen los datos que se evalúan de forma directa en las preguntas del examen (Preguntas 1 a 50 y Casos Clínicos A y B). Luego, utilice el mapa de preguntas y conceptos y el vocabulario bilingüe al final para dominar la terminología clínica.

1. Lesiones de Tejidos Blandos e Infecciones Virales (HPV y Virus Varicela-Zóster)

- **Gránulos de Fordyce:** Glándulas sebáceas ectópicas que aparecen como pápulas elevadas de color blanco a amarillo en áreas sin pelo. Presentes en la mayoría de los adultos en la mucosa bucal y el borde bermellón. **Aparecen durante la pubertad debido al estímulo de las hormonas androgénicas** (no presentes en niños antes de la pubertad).
- **Liquen Plano Oral:** Enfermedad mucocutánea crónica. La variante más común es el **liquen plano reticular**, caracterizado por líneas blancas en encaje (**estrías de Wickham**). La forma erosiva cursa con dolor y lesiones gingivales intensas.
- **Virus Varicela-Zóster (VZV):** La reactivación del virus latente causa la **Culebrilla (Shingles)**. El virus Herpes Simplex tipo 1 (HSV-1) causa el herpes labial y la gingivoestomatitis herpética primaria. El Coxsackievirus causa la herpangina.
- **Leucoedema vs. Mordedura de Mejilla (Morsicatio buccarum):** El leucoedema se debe a edema intracelular y **desaparece cuando la mucosa se estira** (apariencia opalescente azulada). La mordedura de mejilla no desaparece al estirar y presenta aspecto macerado/irritado.
- **Fibroma por Irritación (Fibroma Traumático):** Lesión exofítica benigna de tejido conectivo fibroso causada por **traumatismo crónico** (ej. mordida recurrente). Sitio más común: **mucosa bucal a lo largo del plano oclusal**, labios y lengua. Más frecuente en **mujeres de 45 años**.
- **Papiloma Escamoso Oral y Verruga Vulgar:** Lesiones exofíticas benignas causadas por el **Virus del Papiloma Humano (VPH / HPV)** con apariencia "**en forma de coliflor**" (proyecciones digitiformes). VPH tipos 6 y 11 causan papilomas; VPH-2 y 4 causan verruga vulgar.
- **VPH Orofaringeo y Cáncer:** VPH (especialmente VPH-16) es el principal factor de riesgo oncológico en la región amigdalina. Más frecuente en **hombres**. La palpación del cuello y conductos salivales es clave porque el VPH tiene afinidad por los conductos salivales.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 38, 39, 40, 48, 50 y CASO A:** * Los **Gránulos de Fordyce** son glándulas sebáceas de color blanco-amarillento en la mucosa bucal; responden a las **hormonas androgénicas en la pubertad**. * El **liquen plano reticular** exhibe un patrón blanco en encaje (estrías de Wickham) y es el tipo más común. * La reactivación del virus varicela-zóster causa **Culebrilla (Shingles)**. * El **leucoedema** desaparece cuando la mucosa se estira. * El **fibroma por irritación** ocurre por trauma crónico en áreas de oclusión (más común en **mujeres de 45 años**). * Las lesiones por VPH en la orofaringe tienen **apariencia de coliflor**, son más comunes en **hombres** y el VPH se aclara en un promedio de **12 meses**. * La **lengua vellosa** se debe al alargamiento de las **papilas filiformes**.

2. Patología de las Glándulas Salivales y Lesiones Asociadas

- **Mucocele (Fenómeno de Extravasación de Moco): Pseudoquiste** (no es un quiste verdadero porque **NO está revestido por epitelio**; el cúmulo de mucina está rodeado por **tejido de granulación**). Ocurre por la rotura traumática de un **conducto de glándula salival accesoria/menor** (ej. mordedura de labio).
- **Ubicación más común: Labio inferior** (lateral a la línea media).
- **Presentación clínica:** Nódulo blando, fluctuante, móvil, no doloroso y lleno de líquido.
- **Ránula:** Término utilizado para un mucocele de gran tamaño ubicado en el **suelo de la boca**, que involucra los conductos de la glándula sublingual o submandibular (conductos de Rivinus o Wharton).
- **Línea Alba:** Línea blanca horizontal sobre la mucosa bucal a lo largo del plano de oclusión, causada por fricción u oclusión.
- **Estomatitis por Nicotina:** Lesión del paladar duro causada por el calor y el humo del tabaco. Se presenta como mucosa blanca queratinizada con **puntos rojos prominentes** (orificios inflamados de los conductos de las glándulas salivales menores).
- **Sialometaplasia Necrotizante:** Lesión benigna caracterizada por necrosis de las glándulas salivales menores del paladar, secundaria a **isquemia vascular por traumatismo o inyección de anestesia local**.
- **Adenoma Pleomórfico (Tumor Mixto Benigno):** Tumor benigno más común de las glándulas salivales (**90% de los tumores benignos**). Ocurre con mayor frecuencia en la **glándula parótida** en adultos (35-55 años). Tiene una tasa de transformación maligna del 5%.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 8, 9, 10, 11, 17, 20 y CASO B:** * El **mucocele** NO es un quiste verdadero porque la mucina **no está rodeada de epitelio**, sino de **tejido de granulación**. * La ubicación más común del mucocele es el **labio inferior**; es una pápula/nódulo móvil, no doloroso y lleno de líquido. * Un mucocele en el suelo de la boca se denomina **Ránula**. * La **estomatitis por nicotina** ocurre en el **paladar duro** (inflamación de conductos salivales menores). * La **sialometaplasia necrotizante** es causada por **isquemia o trauma por anestesia local**. * El **adenoma pleomórfico** es el tumor salival más común y ocurre en la **glándula parótida**.

3. Quistes Odontogénicos y No Odontogénicos del Cabeza y Cuello

- **Quiste Radicular (Periapical):** El quiste odontogénico **más común de todos** (60-70%). Se forma en el ápice de un diente no vital como resultado de necrosis pulpar e inflamación.
- **Quiste Dentígero (Folicular):** El **segundo quiste odontogénico más común**. Es un quiste de desarrollo que se forma alrededor de la corona de un diente retenido o no erupcionado (frecuentemente **terceros molares inferiores**).
- **Quiste Residual:** Quiste que persiste después de la extracción incompleta de un diente que tenía un quiste radicular.
- **Quiste Óseo Simple (Quiste Traumático):** Cavidad intraósea sin revestimiento epitelial (pseudoquiste). Radiográficamente muestra una imagen radiolúcida con **borde festoneado que rodea las raíces de los dientes**. Tratamiento: **legado quirúrgico** para inducir sangrado y cicatrización ósea en 6 meses.
- **Quiste del Conducto Tirogloso:** Quiste de desarrollo ubicado en la **línea media del cuello**. Más común en adultos jóvenes (<20 años). La prueba clínica más importante es un **examen palposcópico completo de la glándula tiroidea**.
- **Quiste Nasolabial:** Quiste de desarrollo de tejidos blandos ubicado en el pliegue mucolabial cerca del canino superior y la base de la nariz.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 18, 19, 21, 22, 23, 46, 47, 49:** * El **quiste periapical/radicular** es el quiste odontogénico más común. * El **quiste dentígero** rodea la corona de un diente no erupcionado (terceros molares) y es un quiste de **desarrollo** (NO inflamatorio). * El **quiste residual** se debe a la remoción incompleta de un diente/quiste previo. * El **quiste óseo simple** muestra un **aspecto festoneado alrededor de las raíces** y se trata con **legrado**. * El **quiste del conducto tirogloso** está en la **línea media del cuello** y requiere examen de tiroides.

4. Anomalías del Desarrollo Dental y Estructuras Óseas

- **Anodoncia y Displasia Ectodérmica:** La displasia ectodérmica es un trastorno hereditario caracterizado por **ausencia congénita de dientes (anodoncia/hipodoncia)**, frecuentemente premolares e incisivos, junto con alteraciones en cabello, uñas y glándulas sudoríparas.
- **Concrescencia:** Anomalía del desarrollo donde dos dientes adyacentes están **unidos únicamente por el cemento radicular**.
- **Fusión:** Unión de dos gérmenes dentales en desarrollo mediante la dentina, resultando en un diente grande con un canal radicular único o dividido.
- **Geminación:** Intento de un solo germen dental de dividirse, dando lugar a una corona bífida con una sola raíz y un solo canal.
- **Dens in Dente (Dens Invaginatus):** Invaginación del epitelio del esmalte hacia la papila dental. Sitio más común: **incisivos laterales superiores**.
- **Dientes Natales:** Dientes presentes al nacer (frecuentemente incisivos centrales inferiores primarios con raíces no desarrolladas e inestables).
- **Amelogénesis Imperfecta:** Trastorno hereditario de la formación del esmalte dividido en 4 tipos (hipoplásico, hipocalcificado, hipomaduración, hipoplásico/hipomaduración/taurodontismo). El tipo **hipocalcificado** es un defecto en la mineralización de la matriz.
- **Abfracción:** Defecto en forma de cuña en el área cervical del diente (**unión amelocementaria / UAC / CEJ**) causado por fuerzas flexurales oclusales.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 14, 16, 34, 35, 36, 37, 42:** * La **displasia ectodérmica** causa la ausencia congénita de premolares y otros dientes. * La **concrescencia** es la unión de dos raíces únicamente por el **cemento**. * El **dens invaginatus (dens in dente)** es más frecuente en **incisivos laterales superiores**. * Los **dientes natales** están presentes al nacer y tienen raíces poco desarrolladas e inestables. * La **abfracción** se observa en el **área cervical de los dientes en la UAC (CEJ)**.

5. Patología Ósea Sistémica y Trastornos Hereditarios/Sanguíneos

- **Torus Palatino y Mandibular:** Exostosis óseas benignas. El torus palatino ocurre en la línea media del paladar duro (etiología genética y masticatoria). El torus mandibularis es más común en **varones jóvenes de 13 a 16 años** en la superficie lingual premolar.
- **Enfermedad de Paget del Hueso:** Trastorno metabólico óseo caracterizado por resorción y aposición ósea desorganizada. Más común en **hombres caucásicos mayores de 50 años** (NO más prevalente en afroamericanos). Causa ensanchamiento del maxilar, separación de dientes y prótesis desajustadas.
- **Osteomalacia y Osteopenia:** La osteomalacia ("huesos blandos") en adultos se debe a deficiencia de vitamina D/calcio. La **osteopenia** es el término para la desmineralización y baja densidad ósea en adultos a lo largo del

tiempo.

- **Hiperparatiroidismo:** Trastorno endocrino caracterizado por hipercalcemia, **tumores pardos (Brown tumors)**, cálculos renales, resorción ósea y pérdida de la lámina dura.
- **Querubismo:** Trastorno autosómico dominante (defecto en el gen SH3BP2) caracterizado por expansión bilateral simétrica de los maxilares en **niños muy pequeños (1 a 5 años)**.
- **Enfermedad de von Willebrand y Hemofilia:** La enfermedad de von Willebrand es una deficiencia autosómica dominante de factores de coagulación que afecta a **hombres y mujeres**. La hemofilia es ligada al X.
- **Anemia Ferropénica (Deficiencia de Hierro):** Presenta palidez mucosa, **queilitis angular, pérdida de papilas filiformes (glositis atrófica)** y sensación de ardor en la lengua.
- **Síndrome de Plummer-Vinson:** Asociado con anemia por deficiencia de hierro, glositis y disfagia.
- **Leucemia Mieloide Crónica (LMC):** Caracterizada por la alteración genética del **cromosoma Filadelfia 22**.
- **Enfermedad de Addison:** Insuficiencia corticoadrenal primaria que produce sobreproducción de melanina y **hiperpigmentación macular parda en la mucosa oral**.

[!NOTE] CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 12, 13, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 44, 45: * La **anemia por deficiencia de hierro** causa pérdida de papilas filiformes, queilitis angular y ardor en la lengua. * El **cromosoma Filadelfia 22** se asocia con la **leucemia crónica**. * El **querubismo** ocurre en **niños muy pequeños** (1-5 años) por mutación del gen SH3BP2. * La **osteopenia** es la desmineralización ósea progresiva en adultos. * El **hiperparatiroidismo** produce tumores pardos, cálculos renales y pérdida de la lámina dura. * La **enfermedad de von Willebrand** afecta la coagulación en hombres y mujeres. * La **enfermedad de Addison** causa pigmentación melanótica oral. * La **enfermedad de Paget** es más común en **hombres caucásicos**.

6. Repaso de Casos Clínicos (Casos A y B)

Caso A: Paciente Jeff (Patología Orofaringea y Disfagia)

- **Historia:** Jeff es un paciente masculino de 30 años, gerente de hotel, que vivió en el extranjero varios años sin atención dental. Perdió dientes por **practicar boxeo sin protector bucal**. Tiene caries y bolsas periodontales de 5 mm.
- **Motivo de Consulta:** Presenta sensación de **llenura en la garganta al tragar** y **disfagia** (dificultad para tragar) desde hace 6 meses **sin dolor**. Inicialmente vio enrojecimiento y ahora observa una placa gruesa y blanca.
- **Examen Oral:** Masa ulcerosa y en forma de placa con **"aspecto de coliflor"** en la orofaringe posterior que bloquea el tejido amigdalino izquierdo.
- **Diagnóstico y Manejo:**
 - La sospecha principal es **Papiloma Escamoso / Carcinoma de Células Escamosas asociado a VPH**.
 - El VPH tiene mayor prevalencia en **hombres** y una tasa de curación temprana del **75% al 85%**.
 - La conducta inmediata es la **remisión urgente a un Otorrinolaringólogo (ORL / ENT)** para **biopsia**.

Caso B: Nódulo en Labio Inferior (Mucocele)

- **Historia y Examen:** Nódulo azulado, elevado, móvil y no doloroso en el labio inferior.
- **Histología:** Moco extravasado rodeado de **tejido de granulación sin revestimiento epitelial**.
- **Diagnóstico:** **Mucocele** causado por la rotura de un conducto salival menor accesorio por traumatismo.

7. Mapa de Preguntas y Conceptos (Preguntas 1 a 50)

Pregunta	Tema Evaluado	Concepto Clave a Recordar
Q1	Gránulos de Fordyce	Pápulas blanco-amarillentas compuestas por glándulas sebáceas en mucosa bucal.
Q2	Liquen Plano Reticular	Forma más común de liquen plano; presenta aspecto blanco en encaje (estrías de Wickham).
Q3	Virus Varicela-Zóster	La reactivación del virus latente causa la Culebrilla (Shingles) .
Q4	Leucoedema	El leucoedema desaparece cuando la mucosa bucal se estira; el mordisqueo de mejilla no.
Q5	Hormonas Androgénicas	Los gránulos de Fordyce se desarrollan en la pubertad estimulados por hormonas androgénicas.
Q6	Fibroma por Irritación	Hiperplasia fibrosa causada por trauma crónico; común en labios, lengua y mucosa bucal.
Q7	Edad del Fibroma	Es más común en adultos de 40 a 60 años (ej. mujer de 45 años).
Q8	Definición de Mucocele	No es un quiste verdadero porque la mucina no está rodeada de epitelio .
Q9	Ránula	Mucocele de gran tamaño en el suelo de la boca que afecta las glándulas sublinguales/submandibulares.
Q10	Línea Alba	Línea blanca queratinizada en la mucosa bucal a lo largo del plano oclusal.
Q11	Estomatitis por Nicotina	Lesión del paladar duro con inflamación roja de conductos salivales menores.
Q12	Etiología del Torus Palatino	Causado por genética y fuerzas masticatorias; bacterias/virus NO son causa .
Q13	Torus Mandibularis	Más común en varones jóvenes de 13 a 16 años en la cara lingual premolar.

Q14	Displasia Ectodérmica	Trastorno hereditario que causa anodoncia/ausencia congénita de premolares.
Q15	Lengua Vellosa	El consumo de xilitol NO causa lengua vellosa; radioterapia, alcohol y antibióticos sí.
Q16	Concrescencia	Unión de dos raíces dentales únicamente por el cemento .
Q17	Adenoma Pleomórfico	Representa hasta el 90% de los tumores benignos de glándulas salivales.
Q18	Quiste del Conducto Tirogloso	La evaluación más importante es el examen palpatorio de la glándula tiroides .
Q19	Edad del Quiste Tirogloso	Se diagnostica comúnmente en adultos jóvenes (<20 años) .
Q20	Adenoma Pleomórfico	Ocurre con mayor frecuencia en la glándula parótida (NO en la submandibular).
Q21	Quiste Odontogénico Común	El quiste radicular (periapical) es el quiste odontogénico más frecuente.
Q22	Quiste Residual	Causado por la remoción incompleta de un diente o quiste radicular previo.
Q23	Quiste Óseo Simple	Se trata con legrado quirúrgico para inducir sangrado y regeneración ósea.
Q24	Anemia Falciforme	Prevalente en afroamericanos y en grupos del Mediterráneo y Asia .
Q25	Cáncer Orofaringeo	El Virus del Papiloma Humano (VPH / HPV) es el principal factor de riesgo.
Q26	Síndrome de Plummer-Vinson	Asociado con anemia por deficiencia de hierro y disfagia.
Q27	Deficiencia de Hierro	Causa palidez, queilitis angular, pérdida de papilas filiformes y ardor lingual.
Q28	Implicación Oral del VIH	La candidiasis oral es la manifestación más común de la infección por VIH (85%).

Q29	Cromosoma Filadelfia 22	Marcador genético de la leucemia mieloide crónica .
Q30	Edad del Querubismo	Se diagnostica en niños muy pequeños (1 a 5 años de edad).
Q31	Riesgo en Querubismo	Riesgo de transformación o desarrollo de sarcoma / lesiones agresivas.
Q32	Pénfigo Mucoso	Requiere evaluación para prevenir daño ocular (cicatrización conjuntival).
Q33	Osteopenia	Término para la desmineralización y reducción progresiva de la densidad ósea en adultos.
Q34	Abfracción	Defecto en forma de cuña ubicado en el área cervical de los dientes en la UAC (CEJ) .
Q35	Amelogénesis Imperfecta	El tipo hipocalcificado es un defecto de mineralización de la matriz de esmalte.
Q36	Concrescencia	Unión de dos raíces durante la formación del cemento radicular.
Q37	Dens Invaginatus	Ocurre con mayor frecuencia en los incisivos laterales superiores .
Q38	Lengua Geográfica	Es una condición benigna que NO tiene componente de malignidad .
Q39	Gránulos de Fordyce	El sitio intraoral más común es la mucosa bucal .
Q40	Lengua Velloso	Causada por el alargamiento e hiperqueratosis de las papilas filiformes .
Q41	Enfermedad de Addison	Insuficiencia adrenal primaria que presenta pigmentación melanótica oral .
Q42	Dientes Natales	Dientes presentes al nacer con raíces poco desarrolladas e inestables.
Q43	Enfermedad de Paget	Es más común en hombres caucásicos (NO en afroamericanos).

Q44	Hiperparatiroidismo	Causa tumores pardos , cálculos renales, resorción ósea y pérdida de lámina dura.
Q45	Enfermedad de von Willebrand	Trastorno hemorrágico hereditario autosómico dominante en hombres y mujeres.
Q46	Quiste Dentígero	Quiste de desarrollo que rodea la corona de un diente retenido (NO es inflamatorio).
Q47	Quiste Nasolabial	Quiste de desarrollo de tejidos blandos en el pliegue mucolabial cerca del canino.
Q48	Aclaramiento del VPH	El cuerpo aclara la infección por VPH en un promedio de 12 meses .
Q49	Aspecto del Quiste Óseo Simple	Muestra un aspecto radiolúcido festoneado alrededor de las raíces dentales.
Q50	Tipo de Liquen Plano	El tipo reticular es el más común (el tipo erosivo causa lesiones gingivales intensas).

8. Vocabulario Clínico Bilingüe (Español – Inglés)

Término en Español	Clinical English Term	Definición y Relevancia Clínica
Disfagia	Dysphagia	Dificultad o malestar para tragar alimentos o líquidos.
Disfonía	Dysphonia	Ronquera o alteración anormal de la voz.
Aspecto de coliflor	Cauliflower-like appearance	Patrón de crecimiento tisular exófito, verrugoso e irregular.
Gránulos de Fordyce	Fordyce granules	Glándulas sebáceas ectópicas de color blanco-amarillento en mucosa bucal.
Mucocele	Mucocele	Seudoquiste causado por rotura de un conducto salival menor; mucina rodeada de tejido de granulación.

Ránula	Ranula	Mucocele de gran tamaño en el suelo de la boca (glándulas sublingual/submandibular).
Estrías de Wickham	Wickham striae	Red de líneas blancas características del liquen plano reticular.
Protector bucal deportivo	Athletic mouthguard	Aparato protector intraoral para prevenir traumatismos dentales en deportes.
Biopsia	Biopsy	Extracción de muestra tisular para análisis histológico de diagnóstico.
Otorrinolaringólogo (ORL)	Otolaryngologist (ENT)	Médico especialista en enfermedades de oído, nariz y garganta.
Concrescencia	Concrescence	Unión de dos dientes adyacentes únicamente por el cemento radicular.
Dens invaginatus	Dens invaginatus (Dens in dente)	Invaginación del esmalte hacia la papila; común en incisivos laterales superiores.
Abfracción	Abfraction	Lesión cervical en forma de cuña en la UAC (CEJ) por flexión oclusal.
Quiste Dentígero	Dentigerous cyst	Quiste de desarrollo alrededor de la corona de un diente no erupcionado.
Quiste Radicular	Radicular cyst (Periapical cyst)	Quiste odontogénico inflamatorio más común, formado en el ápice de un diente no vital.
Querubismo	Cherubism	Trastorno genético autosómico dominante con expansión bilateral de maxilares en niños.
Tumor Pardo	Brown tumor	Lesión lítica ósea característica del hiperparatiroidismo.
Cromosoma Filadelfia	Philadelphia chromosome	Translocación entre cromosomas 9 y 22, diagnóstica de leucemia mieloide crónica.
Glositis Atrófica	Atrophic glossitis	Pérdida de papilas filiformes en la lengua asociada con anemia ferropénica.

9. Repaso Rápido de Datos de Alto Rendimiento

- **Gránulos de Fordyce** → Glándulas sebáceas en mucosa bucal estimuladas por **hormonas androgénicas en la pubertad**.
- **Liquen Plano Reticular** → Tipo más común; presenta **estrías de Wickham** (líneas blancas en encaje).
- **Leucoedema** → Opalescencia azulada que **desaparece al estirar la mucosa**.
- **Fibroma por Irritación** → Lesión por trauma crónico en línea oclusal; más común en **mujeres de 45 años**.
- **VPH Orofaringeo** → Lesiones con **aspecto de coliflor**; más común en **hombres**; el VPH se aclara en **12 meses**.
- **Mucocele** → **Seudoquiste** (sin epitelio, rodeado de **tejido de granulación**); sitio más común: **labio inferior**.
- **Ránula** → Mucocele grande en el **suelo de la boca**.
- **Estomatitis por Nicotina** → Lesión del **paladar duro** con puntos rojos (orificios salivales inflamados).
- **Adenoma Pleomórfico** → Tumor salival benigno más común (**90%**); se ubica en la **parótida**.
- **Quiste Radicular** → Quiste odontogénico **más común** (ápice de diente no vital).
- **Quiste Dentígero** → Rodea la corona de un diente retenido; quiste de **desarrollo**.
- **Quiste Óseo Simple** → Muestra **borde radiolúcido festoneado** alrededor de las raíces; se trata con **legrado**.
- **Quiste del Conducto Tirogloso** → En la **línea media del cuello**; requiere **palpación de tiroides**.
- **Displasia Ectodérmica** → Causa **anodoncia/ausencia congénita de premolares**.
- **Concrescencia** → Unión de dos raíces únicamente por el **cemento**.
- **Dens in Dente** → Más frecuente en **incisivos laterales superiores**.
- **Abfracción** → Lesión cervical en la **UAC (CEJ)** por flexión oclusal.
- **Anemia Ferropénica** → Causa **pérdida de papilas filiformes**, queilitis angular y ardor lingual.
- **Cromosoma Filadelfia 22** → Marcador genético de **leucemia mieloide crónica**.
- **Querubismo** → Expansión bilateral de maxilares en **niños muy pequeños (1-5 años)**.
- **Hiperparatiroidismo** → Causa **tumores pardos**, cálculos renales y pérdida de lámina dura.
- **Caso A (Jeff)** → Disfagia + llenura de garganta + masa en coliflor en orofaringe = **Remisión urgente a Otorrinolaringólogo (ORL) para biopsia**.